

ІННОВАЦІЯ онкологічна клініка 		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО 36076865												
ТОВ "Медична клініка "Інновація" тел. (044) 331-21-00, (067) 503-59-22 Ліцензія АЕ 459319 від 27.08.2014 видана МОЗ України www.innovacia.com.ua	ІННОВАЦІЯ онкологічна клініка 	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 0 2 8 / о Затверджена наказом МОЗ України 14.02.2012 р. № 110												
Епікриз														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Пациєнт Жерліцина Анастасія Станіславівна , 46 років</td> <td>СК</td> </tr> <tr> <td>Телефон № (м):0685975246</td> <td>Поліс №</td> </tr> <tr> <td>ЕМК № 7140773</td> <td>Координатор</td> </tr> <tr> <td>Документ № IX-230228/5668.E1/1</td> <td>Від 02.03.2023 17:21:00</td> </tr> <tr> <td>Картка № Стационарна карта №IX-230228/5668 від 02.03.2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Відділення Поліклінічне відділення</td> <td>Лікар Лациннікова Оксана Миколаївна</td> </tr> </table>			Пациєнт Жерліцина Анастасія Станіславівна , 46 років	СК	Телефон № (м):0685975246	Поліс №	ЕМК № 7140773	Координатор	Документ № IX-230228/5668.E1/1	Від 02.03.2023 17:21:00	Картка № Стационарна карта №IX-230228/5668 від 02.03.2023		Відділення Поліклінічне відділення	Лікар Лациннікова Оксана Миколаївна
Пациєнт Жерліцина Анастасія Станіславівна , 46 років	СК													
Телефон № (м):0685975246	Поліс №													
ЕМК № 7140773	Координатор													
Документ № IX-230228/5668.E1/1	Від 02.03.2023 17:21:00													
Картка № Стационарна карта №IX-230228/5668 від 02.03.2023														
Відділення Поліклінічне відділення	Лікар Лациннікова Оксана Миколаївна													
Пациєнтка Жерліцина А. С. , 1976р.н., знаходилася на лікуванні 02-03.03.2023р. в умовах стаціонару клініки "Інновація". Діагноз: Лейоміосаркома матки T2NxM1 (печінка, брюшина). Стан після трепан-біопсії печінки 28.08.2022 р. ПГЗ:лейоміосаркома матки. Стан після 4-х циклів хіміотерапії по протоколу Гемцитабін+Доцетаксел+Авастин з прогресією в печінці (МРТ ОЧП, ОМТ 14.10.2022, КТ 01.12.2022). Виявлено мутації Kit, MET (повногеномне секвенування ONCOMINE, 12.2022). Лікування Пазопанібом 05-12.01.2023р. з розвитком синдрому задньої зворотної енцефалопатії та позитивною динамікою по даним КТ від 09.02.2023р. Заключення: КТ-ознаки вторинного ураження паренхіми печінки, міжпетельний імплант лівого мезогастрія, об'ємне утворення в проекції правого яєчника (імплант в Дугласовому просторі?), мінімальні ознаки біліарної гіпертензії. Від 04.01.2023р динаміка позитивна - регрес вогнищ в печінці на 12%, зменшення в розмірах міжпетельного імпланту на 15%. Повторна біопсія печінки (23.01.2023). ПГЗ: метастаз лейоміосаркоми матки. Супутний діагноз: Залізодефіцитна анемія. Цукровий діабет 2 тип. Гіповітаміноз Д. Закритий відламковий перелом дистального метаепіфізу лівої променевої кістки зі зміщенням відламків (11.02.2023р.) Актуальна госпіталізація: 2-й цикл хіміотерапії за протоколом Трабектідин (редукція дози на 20%). 13.02.2023р. -імплантована система для внутрішньовенних інфузій Port-A-Cat. Активні скарги на момент огляду відсутні. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Шкірні покриви і видимі слизові оболонки звичайного забарвлення, чисті. Дихання везикулярне, вислуховується на всьому протязі, хрипів немає. Діяльність серця ритмічна, тони звучні. Живіт м'який, безболісний при пальпації, печінка збільшена до рівня пупка, активна перистальтика. Діурез - достатній, стілець- без особливостей. У рамках 2-го циклу хіміотерапії пацієнтка отримала Йонделіс 2 мг. Супровідна терапія включала дексаметазон, еменд, зофран, контролок, сольові розчини еліквіс, глюкофаж, сорбіфер, тивортин, гептрал, сольові розчини, Кальцій+ДЗ. Лікування перенісла задовільно. Результати аналізів надані. 3-й цикл хіміотерапії заплановано на 23.03.2023р. Рекомендовано: 1.При нудоті - Зофетрон по 8 мг (1 таб) всередину 3 рази на день 3 дні, потім по потребі,, максимальна добова доза - 32 мг (4 таблетки на добу), також можливий прийом Церукалу по 10-20 мг (1-2 таблетки), до 6 таблеток на день, у 2-3 прийоми. 2.При явищах мукозиту (почервоніння, набряклість, виразка слизової ротової порожнини) - почати обробку ротової порожнини оральними антисептиками (орасепт, гивалекс, стоматидин), при погіршенні стану - дифлюкан по 150 мг всередину (за узгодженням).														

- 3.Дотримання питного режиму - вживання не менше 2 -2.5л рідини на добу (під контролем діурезу та показників артеріального тиску!)
- 4.При сухості шкіри – використання жирних кремів та косметичних масел, при сухості кон'юнктиви – краплі «Штучні сльози» або «Хіло-Кеа». При сухості слизової носа – спрей «Аква-Марис» або «Х'юмер», «Марімер», масляні розчини хлорофіліпту, масло обліпихи, оливкова олія. Обробляти слизову оболонку носа синтоміциновою маззю 2-3 рази на день 10 днів.
5. Загальний аналіз крові 1 раз на тиждень.
- 6.При підвищенні температури тіла вище 380С, розпочати антибактеріальну терапію (за погодженням з лікарем!!!).
- 7.При запорах - Дуфалак по 20 мл 1 раз на день щодня після сніданку.
- 8.При проносі почати Імодіум-2 капс. одразу, потім по 1 капс. після кожного епізоду рідкого випорожнення (до 8 капс на добу).
- 9.При погіршенні самопочуття-тел. чергового лікаря 096 8151618
10. Сорбіфер по 1 таб 1 раз на день за 30 хв. до їжі щоденно.
11. Еліквіс по 2.5 мг 2 рази на день тривало.
- 12.Віт д3 по 4 тис Од/день 3 міс суммарно.
- 13.Виконувати рекомендації травматолога.
- 14.Виконувати рекомендації ендокринолога.
15. Гептрал по 500 мг 2 рази на день (ранок, обід).
16. КальційД3 по 1 таб 2 рази на день під час прийому їжі.
17. Еменд 80 мг вранці 04.02.2023р.
18. Зарсіо по 30 млн п/ш 05-06.03.2023р., за 30 хв. до ін'єкції прийняти парацетамол 500 мг. Для використання зберігати в холодильнику.
19. Урсофальк по 500 мг щовечора.

Клінічний діагноз

Основний: Діагноз: Лейоміосаркома матки T2NxM1 (печінка, брюшина).

Лікар _____ /Лаціннікова О.М./